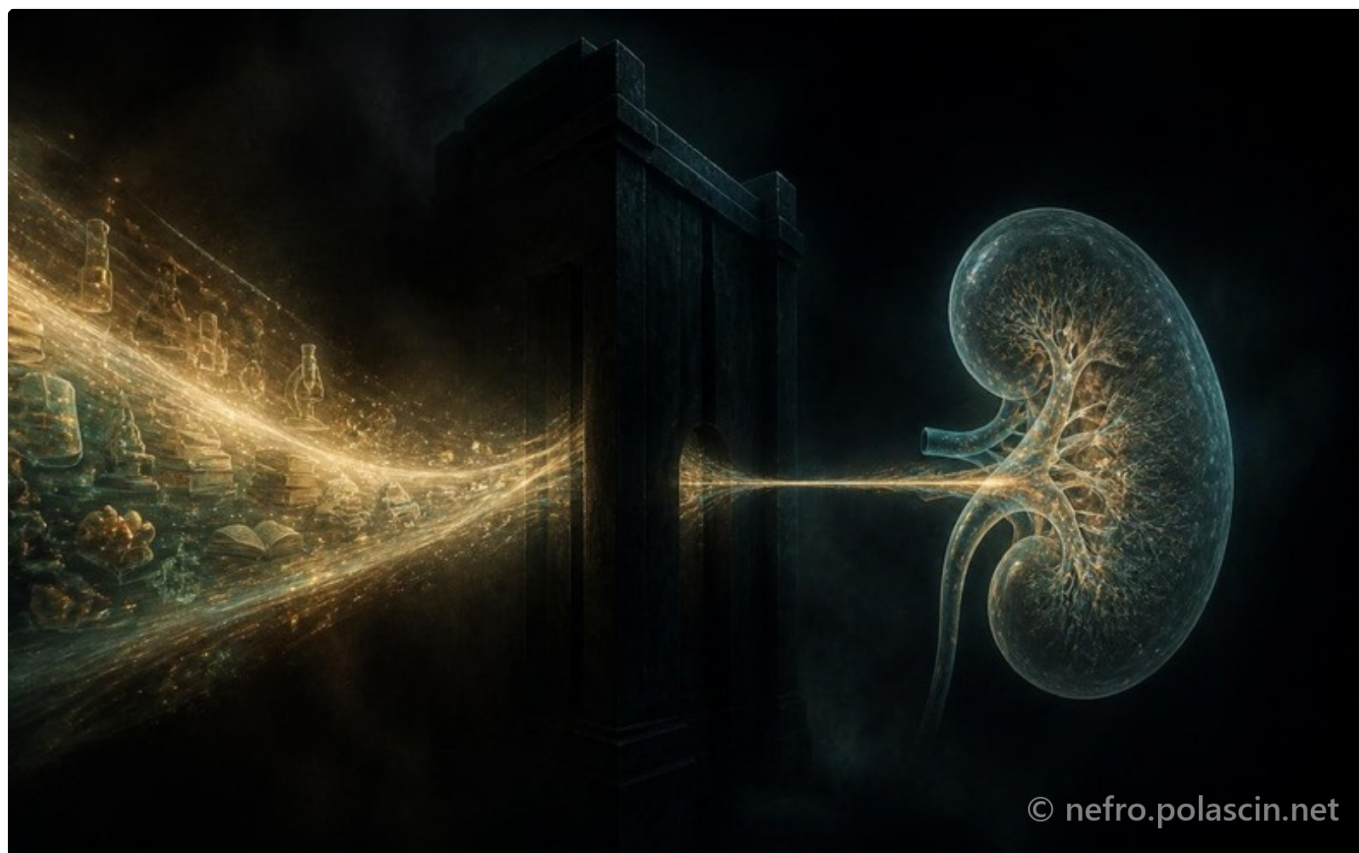


Nová ADA ako impulz na reflexiu: výskumné granty, politický zásah a dopad na nefrológiu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Ilustračná scéna. Keď sa zúži financovanie výskumu, dôsledky sa prejavajú až o roky — a nesie ich pacient.

Prečo je to relevantné pre nefrológiu

Klinická nefrológia sa často diskutuje cez diagnózy, liečbu a komplikácie. To podstatné však býva aj „mimo ambulancie“: stabilita výskumného ekosystému, dostupnosť grantov a schopnosť vedeckej komunity rýchlo pretavovať výsledky do praxe. Diabetes mellitus, najmä jeho chronické mikrovaskulárne poškodenie, je pritom jedným z hlavných motorov chronického ochorenia obličiek.

Článok na Medscape („The New ADA: I Prefer the Old One“) nie je primárne odborná klinická kazuistika. Je to autorova reflexia a kritika smerovania American Diabetes Association (ADA) v kontexte jej rozhodnutí počas ADA Scientific Sessions. Pre nefrológa je zaujímavé najmä to, že autor spája konkrétne udalosti s širšou témou dopadov škrtov a politizácie výskumu na vývoj diabetologických a s nimi súvisiacich renálnych terapií.

Čo autor v texte opisuje

Autor Irl B. Hirsch (MD) opisuje svoje osobné stanovisko a udalosti spojené s ADA Scientific Sessions. V centre pozornosti sú podľa neho kroky vedenia ADA, ktoré vyústili do odobratia a zhabania identifikačných kariet viacerým účastníkom. Autor to spája s distribúciou editoriálu (úvodníka) z časopisu *Diabetes Care* a s tým, že editoriál mal podľa jeho názoru komunikovať dopady škrtov v oblasti výskumu (NIH) na diabetologický výskumný „pipeline“.

Autor zároveň rámcuje pozadie tým, že hlavným rečníkom (keynote) mal byť Jay Bhattacharya a následne bol nahradený Richardom Woychikom. Text obsahuje aj širšiu politickú rovinu okolo priorit a smerovania výskumu.

Hlavná myšlienka: nejde len o jednorazovú konfliktnú situáciu

Z nefrologického pohľadu je dôležité, že autor nepíše len o „jednom dni“ či o protokole podujatia. Jeho argument sa opiera o tézu, že zásahy do výskumu a grantového prostredia môžu mať dlhodobý efekt: spomalenie objavov, zníženie počtu projektov a posun priorít od základného a translačného výskumu ku krátkodobým alebo politicky „preferovaným“ smerom.

Pri chronických ochoreniach, ako je diabetes s renálnymi dôsledkami, sú práve dlhšie časové horizonty kľúčové. Výsledky z laboratória a klinických štúdií sa do praxe bežne dostávajú až s odstupom rokov.

Prepojenie na diabetologickú a nefrologickú prax

Aj keď text Medscape nie je primárne zameraný na nefrológiu, nefrologická komunita sa s dopadmi výskumného prostredia stretáva nepriamo:

- **Diabetická choroba obličiek:** pokrok v prevencii a liečbe CKD pri diabete stojí na výskume biomarkerov, mechanizmov progresie a na klinických skúšaníach.
- **Včasná intervencia a riziková stratifikácia:** ak sa zníži objem výskumu, môžu sa spomaliť aj inovácie v tom, ako identifikovať pacientov s rýchlou progresiou.
- **Dostupnosť dôkazov pre klinické odporúčania:** menej grantov môže znamenať menej kvalitných dát, čo sa môže prejavíť v neskoršom aktualizovaní odporúčaní.

Ako čítať tento typ textu bez rizika nadinterpretácie

Treba povedať, že ide o autorovo osobné stanovisko a opis udalostí z jeho perspektívy. To znamená:

1. Nie všetky tvrdenia treba automaticky brať ako „hotové fakty“, ak nie sú podložené nezávislými záznamami alebo formálnymi dokumentmi.
2. Ak má článok slúžiť ako podklad do odbornej diskusie, je vhodné doplniť ho o primárne zdroje (vyhlásenia organizátorov, stanoviská, oficiálne recenzie a verejne dostupné informácie).

Praktické ponaučenie pre klinickú komunitu

Podľa autora je jadrom problému to, že organizácia by mala smerovať k vlastnej misii a k udržiavaniu priestoru pre vedeckú diskusiu. Pre nefrológiu to v praktickej rovine prináša otázku, ako udržať:

- **stabilitu financovania výskumu** na dlhé obdobia,
- **ochranu akademickej slobody** a transparentnosť hodnotenia,
- **dôraz na misijnú podstatu** odborných spoločností a časopisov.

Ak sa tieto prvky oslabia, dopad sa časom preniesie aj do kvality dôkazov, ktoré používame v každodennej starostlivosti o pacientov s diabetickým aj nediabetickým poškodením obličiek.

Záver

Text z Medscape predstavuje kritickú reflexiu smerovania ADA a spája ju s väčším príbehom o tom, ako výskumné granty, politická klíma a rozhodnutia odborných organizácií môžu formovať budúcnosť diabetológie a nepriamo aj nefrológie. Pre nás je hlavná správa jednoduchá: stabilita výskumu nie je abstraktná téma, ale podmienka, aby sa nové poznatky dokázali včas premeniť na lepšiu starostlivosť o ľudí s chronickým ochorením obličiek.

Poznámka k presnosti a overovaniu

Tento článok je prehľad a komentár vychádzajúci zo zdroja Medscape. Pri konkrétnych konfliktných tvrdeniach (kto, kedy a prečo konal) je rozumné overiť detaily v primárnych materiáloch organizácie a v nezávislých prehľadoch.

Zdroj: Irl B. Hirsch, *The New ADA: I Prefer the Old One*, Medscape (2026). [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=nova-ada-vyskumne-granty-politicky-zasah-dopad-na-nefrologiu> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.